Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53)3026-8500 - (53) 99979-2839 - Email: frpelotas3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5031935-08.2024.8.21.0022/RS

AUTOR: JANE BEATRIZ DIAS HARDT

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

JANE BEATRIZ DIAS HARDT, já qualificada, ajuizou ação condenatória em desfavor de **UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA** , por igual qualificada, alegando, em síntese, de ser portadora de Fibrose Pulmonar secundária a Artrite Reumatóide Grave – CID 10 J 84.1, patologia diagnosticada no ano de 2021. Disse que se trata de doença pulmonar grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse, motivlo pelo qual lhe foi prescrito o medicamento Nintendanibe. Esclareceu que referido medicamento apresenta evidência científica para tratamento, sendo atualmente autorizado para uso no Brasil, com tempo de uso indeterminado, bem como que sua utilização é preconizada pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática, com o objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Ressaltou que a doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento. Aduziu que solicitou administrativamente o medicamento à ré mas que o pleito foi negado por se tratar de medicamento de uso domiciliar, e que, embora o fármaco seja expressamente arrolado pela agência reguladora, possui indicação apenas para tratamento oncológico, não havendo obrigatoriedade de cobertura para quadros de saúde distintos dos constantes na norma – conforme o caso em testilha. Alegou não ter condições financeiras de arcar com o medicamento, fazendo considerações sobre o direito à saúde e aduzindo que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS constitui apenas a referência básica para os planos privados, e que, ao contrário do alegado, o prescrito para a patologia que acomete a demandante pelo médico assistente, consoante registro na ANVISA, está incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadrando-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento de uso domiciliar. Pugnou, em sede de tutela de urgência, seja determinado à ré a concessão do medicamento Nintedanibe – 150 mg, para uso diário e contínuo, e, como tutela definitiva a confirmação da liminar. Juntou procuração e documentos.

Foi concedido o pedido de gratuidade judiciária e deferido o pedido de tutela de urgência.

Irresignada com o decisum, a ré interpôs recurso de agravo de instrumento que restou provido, sendo que contra tal decisão foi interposto recurso especial que se encontra em tramitação.

A requerida, então, apresentou contestação impugnando o valor da causa. No mérito, defendeu a ausência de cobertura na hipótese, para tratamento domiciliar. Defendeu, ainda, a ausência de contratação específica, esclarecendo que a ANS, através da RN/ANS n°487, de 28/03/20228 , estabeleceu a possibilidade de contratação (por parte dos beneficiários de planos de saúde) de pactos acessórios, voltados, especificamente, a conceder cobertura para medicação (em geral) de uso domiciliar, o que inocorreu na hipótese. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica.

Foi acolhida a impugnação ao valor da causa, invertido o ônus da prova e determinada a intimação das partes para dizer sobre o interesse na produção de outras provas, havendo estas pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

1. O feito tramitou regularmente, não havendo quaisquer nulidades a serem declaradas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes preliminares para desate, procedo ao exame do mérito.

2. A questão é singela e tenho que os pedidos deduzidos na exordial merecem acolhimento.

Com efeito, conforme já restou assentado na decisão que deferiu o pedido liminar, comprovada a relação negocial mantida entre as parte, bem assim a negativa do fornecimento do medicamento, conforme documentos carreados com a vestibular.

Também comprovado o fato de que a autora está acometida da doença informada evento 1, LAUDO17, sendo juntada a prescrição do medicamento evento 1, LAUDO17

De se dizer, nesse passo, que também resta claro pela prova carreada, se tratar de questão de grande gravidade, considerando que a doença que acomete a autora é de rápida progressão, havendo evidências científicas, conforme evento 1, NOTATEC25, que o medicamento discutido reduz o ritmo de avanço da doença.

3.2. Sobre o uso do nintedanibe no tratamento de pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo: O medicamento nintedanibe possui atividade antifibrótica pulmonar. O seu uso foi amplamente estudado no tratamento da fibrose pulmonar idiopática, que é um tipo de doença pulmonar fibrosante grave. Os estudos mostraram que o nintedanibe foi capaz de

retardar a evolução da fibrose pulmonar em pacientes com essa patologia (sem efeito curativo, apenas reduzindo a velocidade de piora da função pulmonar)2

(...)

4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA Reduzir o ritmo de declínio da capacidade vital forçada pulmonar em pacientes com doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo.

A discussão a ser travada, então, diz com a possibilidade ou não de fornecimento do fármaco, considerando que se trata de mediamento de uso domiciliar.

Pois bem.

Embora o art. 10 da Lei 9.656/98 apresente, dentre as hipóteses expressas de possibilidade de exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, há exceção em relação aos medicamentos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care* (inciso VI).

Na hipótese, o medicamento postulado, Nintedanibe, embora de uso domiciliar, está previsto no Rol da ANS para patologia distinta (câncer de pulmão). Contudo, diante da aplicação do CDC ao em tela, reputa-se indevida a diferenciação do consumidor/segurado, apenas pelo fato de sua moléstia ser diversa (Fibrose Pulmonar Idiopática).

Dito isto, com a devida vênia do juízo *ad quem*, que proveu o recurso da ré para indeferir o pedido liminar, entendo mais adequado o entendimento do STJ sobre a matéria que aduz ser possível a concessão do medicamento questionado para a fibrose pulmonar, considerando, em especial, que a recusa da operadora se faz apenas com base na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS para o tratamento de fibrose pulmonar, sem a indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente, afigurando-se, portanto, abusiva.

Nesse sentido, valho-me das bem lançadas razões do Ministro Raul Araújo nos autos do AgInt no AREsp 2705037 / RN, os quais adoto, como parte das razões de decidir:

Cinge-se a controvérsia em verificar se o medicamento OFEV (NINTEDANIB) deve ser custeado pelo plano de saúde para tratamento de fibrose pulmonar - que acomete o beneficiário. A sentença julgou procedente o pedido do agravante para condenar o plano de saúde ao custeio do tratamento, com a respectiva utilização do medicamento, conforme prescrição médica. Ao julgar a apelação interposta pela parte ora agravante, o eg. TJ-RN manteve a condenação da operadora do plano de saúde, nos seguintes termos:

> *"A seu turno, o laudo médico (Id. 21489653) colacionado aos autos é claro e contundente ao afirmar a necessidade de utilização do medicamento NINTEDANIBE, ante a gravidade como a doença se manifesta para o apelante, senão vejamos: O paciente MARCOS SOARES BRANDÃO, 69 anos, comerciante aposentado, é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com quadro clínico altamente compatível com a doença, ou seja falta de ar, ao pequenos e médios esforços e (...)Teste detosse seca crônica e de caráter progressivo. função pulmonar com distúrbio restritivo – com CVF – Capacidade Vital Forçada de 57% do previsto (Restrição de grau Moderado), também condizente com a patologia fibrosante, responsável pelos sintomas de falta de ar e diminuição da capacidade de exercícios, que ocorre nas doenças intersticiais fibrosantes com padrão PIU comum na FPI. (...) A FPI pelo seu comportamento progressivo, evolui para Insuficiência respiratória crônica com queda progressiva da função pulmonar e perda da qualidade de vida. (...) Não há cura para a FPI. O tratamento visa reduzir o inevitável declínio da função pulmonar, decorrente da fibrose (perda da elasticidade) dos pulmões. O curso essencialmente debilitante e fatal da FPI, juntamente com a histórica falta de opções de tratamento, contribui para o mal prognóstico dos pacientes, sendo a taxa de sobrevida em 3 anos. O NINTEDANIB (OFEV), um inibidor específico da Tirosona quinase, tem ação antifibrótica, indicada para tratamento da fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) em adultos. Utiliza-se dose de 150mg (1comp) duas vezes ao dia. Serão cerca de 60 cápsulas/mês (1 caixa/60 caps cada). O tratamento deve ser contínuo. NINTEDANIB – OFEV, já tem registro na ANVISA e tem eficácia já comprovada em estudos que demonstram que a mesma reduz significativamente o declínio da função pulmonar em aproximadamente 50%, redução das exacerbações da doença e melhora na qualidade de vida dos pacientes. (...) Com o tratamento objetivase diminuição dos sintomas clínicos, estabilização funcional com melhora da qualidade de vida e menor risco de exacerbações. Em se tratando de FPI, identificamos grupos de pacientes com evolução rápida e outros com evolução mais lenta, além de apresentarem episódios de exacerbação aguda, quando então há piora clínica destes pacientes em virtude deste evento. ,Não existe paciente estável pois todos perdem função pulmonar em diferentes velocidades. Sobretudo, não é possível prever qual será a evolução do paciente, pois mesmo os que estão com uma perda lenta de CVF estão sob o risco de exacerbação aguda. A não utilização do medicamento, pressupões que o paciente poderá ter sua função pulmonar reduzida nos meses subsequentes, bem como risco de ter uma exacerbação aguda com elevado risco . (grifos acrescidos)de morte Dessa forma, verifica-se que inexistem dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico do apelante, conforme comprova o laudo transcrito parcialmente, tendo ficado evidente que a não utilização do medicamento poderá acarretar ainda mais piora nos sintomas do autor. Em recente julgamento dos Embargos de divergência dos R Esp 1886929, e R Esp 1889704, o STJ, por sua Segunda Seção, decidiu que o rol de procedimentos da ANS, em regra é taxativo, mas havendo exceções para a necessidade de cobertura de procedimentos excluídos do referido rol, no caso, se o plano de saúde comprovar possuir no referido Rol procedimentos e tratamentos equivalentes ao prescrito para o paciente, com eficácia comprovada para o tratamento da enfermidade, além de possuir a mesma efetividade do tratamento prescrito, bem como o procedimento previsto no rol é seguro para o tratamento do paciente, assim a substituição não acarretará danos ao tratamento da enfermidade. Assim, demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao demandante, através da solicitação pelo profissional de saúde que lhe acompanha, em razão de suas condições específicas, deve esse elemento técnico se sobrepor às escolhas firmadas pela operadora de saúde ora recorrente. Mister esclarecer que o fármaco NINTEDANIB (OFEV), para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, diferentemente do afirmado pelo plano de saúde apelante, foi incluído como de cobertura obrigatória pelas operadoras/seguradoras de saúde a partir de 1º de abril de 2021, pela RN-ANS 465/2021, em seu anexo II." (fls. 382/384)*

De fato, não se desconhece o entendimento firmado pela eg. Quarta Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2019, DJe de 20/2/2020), acerca da limitação da responsabilidade das operadoras do plano de saúde em face do rol de procedimentos mínimos e obrigatórios da ANS. Todavia, o voto condutor do mencionado julgamento ressalva a possibilidade de, em situações excepcionais, reconhecidas em decisão fundamentada, ser possível que o Juízo determine o fornecimento de cobertura considerada imprescindível.

Nesse mesmo sentido, posteriormente, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022), reafirmou o entendimento acima delineado fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia acerca da cobertura de tratamentos

médicos pelos planos de saúde:

> *1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;*
>
> *2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;*
>
> *3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;*
>
> *4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luzda medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS*

Logo em seguida, foi editada a Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs sobre a alteração da Lei 9.656/98, para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o ***referido rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde****, e que a cobertura de tratamentos que não estejam previstos no rol* ***deverá ser autorizada*** *pela operadora de planos de assistência à saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confirase, a propósito, a nova redação da Lei 9.656/98, in verbis:*

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...)*
>
> *§ 12.* ***O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde*** *contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> *§ 13.* ***Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde****, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."*

Nesse cenário, conclui-se que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em ***critérios técnicos****, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.*

Na hipótese em exame, o acórdão estadual, de forma expressa, considerou a existência da excepcional necessidade de cobertura, uma vez que o beneficiário possui doença grave - fibrose pulmonar idiopática. Sobre a questão, conforme o atual entendimento desta Corte Superior, de fato, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, ***salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados)****, a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Nesse sentido:*

> *"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOME CARE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.*
>
> *1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.*
>
> *2. No que diz respeito ao medicamento de uso domiciliar, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Viilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).*
>
> *3. Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.019.333/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, g.n.)*
>
> *"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.*
>
> *1. A decisão monocrática que nega provimento a recurso especial com base em jurisprudência consolidada desta Corte encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.*
>
> *2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os*

incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.028.349/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. M EDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.

5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.

6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021, g.n.)

Com efeito, em consulta ao site da Anvisa, verifica-se que o medicamento foi registrado, não se caracterizando, portanto, como tratamento off label.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que seja tratamento off label, ou utilizado em caráter experimental. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados recentes desta Corte:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSIDERADO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o conhecimento do segundo agravo interno interposto, pois, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, só se admite um recurso contra uma única decisão judicial, salvo os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Em ocasião anterior assentou-se nesta Corte que "é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental.

3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.943.693/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, g.n.)

Nesse cenário, observa-se, portanto, que o mencionado medicamento é um antineoplásico oral, com indicação expressa para o tratamento da doença grave que acomete o beneficiário, de modo que a recusa de cobertura com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS para o tratamento de fibrose pulmonar, sem a indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente, afigura-se abusiva, aplicando-se aqui a mesma ratio dos medicamentos off label.

Desse modo, segundo os fatos definitivamente delineados, constata-se a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual é impositivo o desprovimento do recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde, nos termos da Súmula 83/STJ.

No mesmo sentido, já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ***FIBROSE PULMONAR. OFEV (NINTEDANIBE). ANTINEOPLÁSICO ORAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO****. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 3. No ponto, cumpre destacar que, conforme jurisprudência desta c. Câmara Cível, o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo, o que foi ratificado pela inclusão do §12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98.* ***4. Não obstante o caráter exemplificativo do Rol da ANS, o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais, das medicações em regime de home care e dos incluídos no rol da ANS. 4. No presente caso, tem-se como devida a cobertura postulada, sobretudo porquanto concernente a medicamento recomendado pela médica assistente, conhecedora das peculiaridades do quadro clínico do autor, e previsto no Rol da ANS, ainda que para patologia distinta (câncer de pulmão), reputando-se absolutamente indevida eventual interpretação restritiva das diretrizes de utilização.*** *5. Outrossim, entre as exigências mínimas previstas na Lei está a cobertura de tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral, segmento no qual se inclui o medicamento Nintedanibe, conforme consta de seu registro na ANVISA. E, estando o medicamento incluído na categoria dos antineoplásicos, enquadra-se na hipótese de exceção prevista pela legislação para cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde. 6. De qualquer sorte, nos termos do § 13, inciso I, do art. 10 da Lei n° 9.656/98, é possível a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 6. In casu, o medicamento postulado é tratamento eficaz para a patologia que acomete a parte autora (fibrose pulmonar), à luz da medicina baseada em evidências. Ainda, destaca-se que o medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com indicação para o tratamento de Fibrose Pulmonar, conforme consta na bula. Além disso, há diversas notas notas técnicas extraídas do sistema e-NatJus favoráveis ao tratamento. 5. De consequência, com fulcro no §11 do artigo 85 do CPC, restam majorados os honorários devidos pela parte ré aos procuradores da parte autora. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 51456679820228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-10-2023) [grifei].*

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. ***NO PRESENTE CASO, A AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM COBRIR OS CUSTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV) - 150 MG, EM RAZÃO DE QUADRO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID 10 J84.1).*** *II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. É LÍCITA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DA UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, NA FORMA DOS ARTS. 10, VI, E 12, I, "C", E II, "G", DA LEI N° 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ. IV. CONFORME SE EXTRAI DA BULA DO MEDICAMENTO OFEV (NINTEDANIBE),* ***O FÁRMACO EM QUESTÃO É INDICADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO, ESTANDO INCLUÍDO NA CATEGORIA DE ANTINEOPLÁSICOS, TENDO SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS ATRAVÉS DA RN Nº 465/2021 QUE DISPÕE SOBRE O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE NO ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. V. APESAR DE O MEDICAMENTO TER SIDO INSERIDO NO ROL DA ANS QUANDO INDICADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO, A EXISTÊNCIA DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, PORQUANTO OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE****. VI. TAMBÉM, É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. VII. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 146392) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE EM PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, COMO É O CASO DA AUTORA. VIII.* ***PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO.*** *APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50042000720228210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-07-2023) [grifei].*

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos na vestibular, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a fornecer a autora o medicamento Nintedanib (Ofev) 150mg, na quantidade e especificação descrita no receituário constante no evento 1, RECEIT18.

Sucumbente, condeno a ré ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários advocatícios em favor do procurador da ré que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade do feito, a desnecessidade de produção de prova oral, o tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em 16/09/2024), e o labor zeloso dos profissionais (art. 85, § 2º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em face da nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade, (art. 1010, §3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Com o trânsito em julgado e, satisfeitas eventuais custas pendentes, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **GERSON MARTINS, Juiz de Direito**, em 10/12/2024, às 16:54:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073484010v16** e o código CRC **63d3a5b7**.